

Como ler o currículo de um médico

O que cada título garante, o que ele não garante, e as duas perguntas que dizem mais que o currículo inteiro.

Para quem procura por currículo — e para quem nunca soube o que olhar.

POR QUE ESTE GUIA EXISTE

Muita gente escolhe médico pelo currículo, e faz sentido: **é a única coisa que dá para ver de fora**. O problema não é olhar o currículo — é não saber o que cada linha dele significa.

Este guia não vai te dizer para parar de olhar. Vai te ensinar a ler. **Se depois disso você continuar querendo alguém com muito título, ótimo — é critério seu, e a Aliviar procura exatamente isso**. O que a gente não quer é você comprar uma palavra achando que comprou outra coisa.

Aqui não há nome de médico, nota, nem ranking. A Aliviar não classifica pessoas.

Primeiro: o piso

CRM E RQE — A ÚNICA COISA QUE VOCÊ DEVE CONFERIR SEMPRE

O CRM diz que a pessoa é médica. O RQE (Registro de Qualificação de Especialista) diz *em qual especialidade* ela pode se apresentar como especialista.

Os dois se conferem de graça, em segundos, no site do Conselho Federal de Medicina ou do CRM do seu estado. Você digita o nome ou o número e vê a situação.

Isto é o piso, não o teto. Ter RQE não diz que a pessoa é boa; não ter RQE na área em que ela te atende é um sinal para perguntar por quê. É a única checagem que a gente recomenda que você faça sozinha, sempre, com qualquer médico — inclusive fora da Aliviar.

Depois: o que cada palavra quer dizer

RESIDÊNCIA MÉDICA

É o treinamento em serviço depois da faculdade, com duração definida e supervisão.

É o que forma o especialista de verdade, e é a linha mais importante do currículo inteiro.

O que garante: que a pessoa passou anos tratando pacientes daquela área, com quem soubesse mais olhando.

ESPECIALIZAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, "CURSO DE"

Aqui as palavras se confundem, e é onde mais se erra. **Uma pós-graduação não é residência.** Um curso de fim de semana e uma formação de dois anos podem aparecer na mesma linha, escritos do mesmo jeito.

O que fazer: não é sobre desconfiar — é sobre perguntar **quanto tempo durou e onde foi.** Duração e instituição dizem quase tudo.

FELLOWSHIP

Formação avançada numa **subárea**, dentro ou fora do país.

O que garante: que a pessoa se aprofundou **naquele assunto específico.**

O que NÃO garante: que ela seja melhor. **Fellowship diz sobre o quê, não quão bom** — e um fellowship em ombro não ajuda em nada se o seu problema é na coluna.

Fora do país não é automaticamente melhor: é diferente, e às vezes é numa doença que aqui é rara.

PUBLICAÇÕES, MESTRADO, DOUTORADO, "PROFESSOR"

Dizem que a pessoa **pesquisa ou ensina.** São ofícios de verdade, e importantes.

O que NÃO garantem: que ela vá te tratar bem. **Pesquisar e cuidar são trabalhos diferentes,** e há gente excelente num e comum no outro — nos dois sentidos.

O que vale olhar: não a quantidade, e sim **o assunto.** Quem publica sobre o *seu* problema costuma estar por dentro do que mudou nele nos últimos anos — e é isso que te interessa, não o número de artigos.

TEMPO DE FORMADO

Sozinho, diz pouco. Trinta anos de joelho não são trinta anos de coluna. O que conta não é há quanto tempo a pessoa é médica — é há quanto tempo ela faz **o que você precisa,** e com que frequência.

HOSPITAL FAMOSO NO CURRÍCULO

Diz onde a pessoa passou. **Não diz o que ela fazia lá, nem por quanto tempo.** Um estágio de um mês e uma chefia de dez anos cabem na mesma linha.

As duas perguntas que valem mais que o currículo inteiro

ANOTE E LEVE PARA A CONSULTA

1. "Quantos casos como o meu o senhor atende por mês?"

Frequência no *seu* tipo de caso é o que mais se aproxima do que você quer saber. É a diferença entre alguém que vê o seu problema todo dia e alguém que vê uma vez por ano.

2. "O que o senhor não atende, e quando encaminha?"

Esta é a que protege você. Um médico que sabe dizer onde termina o trabalho dele é um médico seguro — e você descobre **agora**, não depois de esperar semanas, se deslocar e pagar a consulta.

Nenhuma das duas está no currículo. As duas se respondem em trinta segundos.

Como a Aliviar trata isso

A GENTE NÃO DÁ NOTA, E NÃO VAI DAR

A Aliviar **não classifica médicos** — não existe "o melhor", não existe ranking, não existe estrela. O que a gente faz é comparar o que **você** disse que importa com o que **cada profissional declarou e assinou** sobre a própria prática.

Cada informação que chega até você vem **com a origem e a data**. Se não deu para confirmar alguma coisa, a gente diz que não deu — **lacuna é dita, nunca preenchida por suposição**.

SE CURRÍCULO É O SEU CRITÉRIO, DIGA

Na conversa com o seu curador, **diga com todas as letras**: "para mim importa formação", "quero alguém que tenha estudado fora", "prefiro quem opere isso toda semana".

Isso vira critério registrado com o seu nome, e entra na comparação do mesmo jeito que qualquer outro. A Curadoria serve o que você declarou — não o que a gente acha que você deveria querer.

Este material é **informativo** e não substitui avaliação médica. Ele não indica, não recomenda e não avalia profissionais — explica o que os termos significam, para você decidir melhor. Escrito em 31/08/2026. Se algo aqui não bater com o que você está vendo, **avise a gente**.